

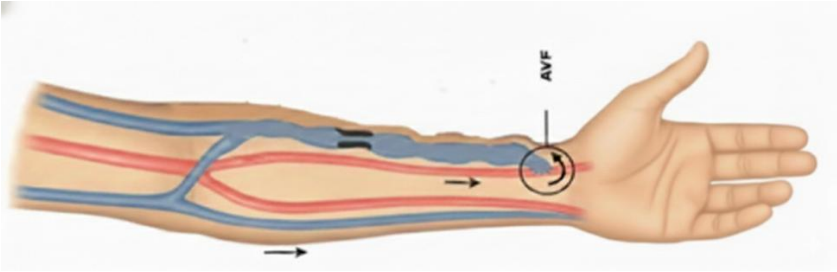
ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL (AVF) BAKIMI

Fistül

Genellikle günlük hayatta az kullanılan koldaki bir atardamar ile toplardamar arasında bağlantı oluşturmak için yapılan küçük bir cerrahi işlemdir.

İşlem sırasında hastanın bayıltılmasına gerek yoktur. İşlem yaklaşık 30 dakika–1 saat içinde tamamlanır.

Ameliyattan 2–3 hafta sonra koldaki damarlar belirginleşip kabarır. Oluşan bu yapıya fistül denir. Diğer bir ifadeyle fistül, hemodiyaliz hastasının yaşam hattı olarak tanımlanabilir.



Arteriyovenöz Fistülde Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar

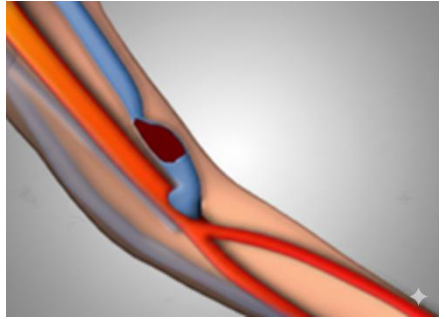
Yetersiz Akım

Arteriyovenöz fistülde yetersiz akımın varlığı pıhtılaşma ve resirkülasyon (yeniden dolaşım) gibi olumsuz durumlara neden olduğu için durumun erkenden tespit edilip tedavi edilmesi fistülün kalınlığı için önemlidir.

Tromboz (Pıhtılaşma)

AV fistüllerde en çok karşılaşılan komplikasyon olan tromboz fistül kayıpları içerisinde %80-85 gibi büyük bir oranı kapsamaktadır.

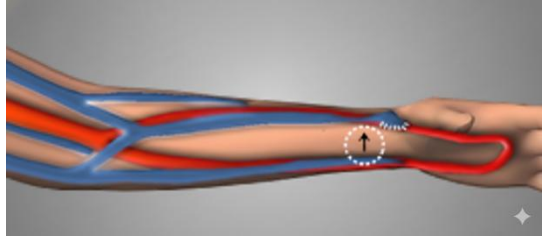
Tromboz damar içinde pıhtılaşma oluşması demektir. Pıhtı cerrahi olarak alınabileceği gibi medikal tedavi ile de uzaklaştırılabilmektedir.



Arteriyovenöz Fistülde Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar

Stenoz (Darlık)

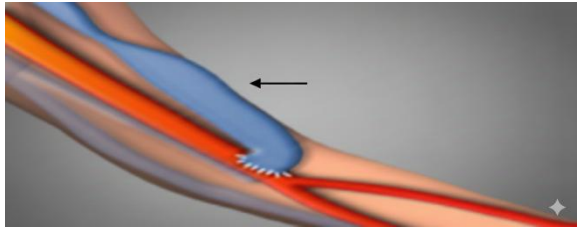
Stenöz trombüs oluşumundaki ana nedenler arasında yer almaktadır.



Damarların daralması anlamına gelmektedir. Diyaliz sonu iğne giriş yerlerinde kan sızmaları olması stenoza neden olabilmektedir. İğne girişinde zorluk yaşanması, fistülli kolda devamlı şişlikler görülmesi gibi nedenler stenozu düşündürebilmektedir.

Anevrizma (Genişleme)

Damarlarda genişlemeyle kendini gösteren bir komplikasyondur.



AV fistülün devamlı kullanımı ile fistül duvarlarında incelmelerin anevrizma oluşmasında etken olduğu bilinmektedir.



Arteriyovenöz Fistülde Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar

İskemi (Kanlanamama)

AV fistül olan kolda damar içinde oluşan yüksek dirençten dolayı kan daha düşük dirençli damarları seçecektir. Bununla birlikte elde ve parmaklarda ağrılarla kendini gösteren iskemi görülecektir.

Enfeksiyon

Enfeksiyon, fistül ameliyatı yapılırken hijyene dikkat edilmemesi, ameliyat ortamında temiz olmayan malzemelerin bulundurulmasıyla bulaşabildiği gibi iğne girişi yapılan bölgelerden de bulaşabilmektedir.

Hemoraji/Hematom (Kanın damar dışına çıkması)

Fistüle giriş yapılan iğnenin fistülde açtığı yara, diyaliz esnasında iğnenin damar dışına çıkması ve diyaliz sonlandırıldıktan sonra iğne yerlerine yanlış bası yapılmasıyla kanın dışarıya sızması durumudur. Bu komplikasyonun meydana gelmesini engellemek için diyaliz sonunda iğne girişine uygun şekilde bası yapılmalıdır.



Fistül bulunan kolunuzla yapmamanız gerekenler

Tansiyon (kan basıncı) ölçümü yaptırmayın!

Kan aldırmayın!

İlaç uygulamayın!

Serum taktırmayın!

Kolunuzu sıkkan giysiler giymeyin!

Çarpmalardan koruyun!

Ağırlık kaldırmayın!

Fistül Bakımı Nasıl Yapılır?



Fistülünüz, tedavinize açılan en önemli kapıdır. Onu korumak, sağlığınıza korumaktır.

Bugün '**Yaşam Hattım**' için neler yaptım?

Diyalize gelmeden önce fistüllü kolunuzu sabah ılık suyla yıkayıp nazıkçe kurulayın.

Fistülün iğne giriş yerinde **kızarıklık, şişlik veya iltihap** fark ederseniz doktorunuza ya da hemşirenize bildirin.

İğne giriş yerlerinin **dönüşümlü kullanılması**, fistülün daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.

Fistüllü kolunuza **çarpma veya travma** olursa ve kanama gelişirse, temiz bir bezle bastırarak **en yakın hastaneye başvurun**.

Kanamayı durdurmak için diyaliz bitiminde iğne giriş yerlerine **bası uygulayın**. Morarma oluşursa **hemşireye haber verin**, tavsiye edilen merhemi kullanın.

Fistüllu kolda titreşim olup olmadığını **günde en az 2** kez kontrol edin.

Fistül olan kolunuzun **soğuk olup olmadığını** gün içinde kontrol edin.

Fistüllu kolunuzu **soğuktan koruyun** ve bu kolun üzerine **yatmayın**.

Sıcaklık farkının olduğu yerlerden **(sauna, kaplıca)** kaçının.

Fistüllu kol ile ağır iş yapılmamalı, **1 kg** üstünde ağırlık kaldırılmamalıdır.

